

Effets indésirables oculaires des psychotropes

👁 Des modifications de la vision ou des mouvements des yeux peuvent survenir lors des traitements psychotropes. Ces effets indésirables sont le plus souvent sans gravité, mais peuvent être gênants dans la vie quotidienne.

👁 La vision floue "de près" est l'effet le plus fréquent, lié à la mydriase (dilatation de la pupille) induite par les psychotropes, principalement ceux ayant un effet anticholinergique. Cet effet sur l'accommodation disparaît avec l'arrêt ou la diminution de la dose des médicaments concernés :

- 📖 antipsychotiques : surtout de 1^{ère} génération (lévomépromazine, cyamémazine, loxapine, chlorpromazine) mais aussi de 2^{nde} génération (clozapine, olanzapine, quétiapine)
- 📖 antidépresseurs : surtout les tricycliques et la paroxétine
- 📖 « correcteurs » antiparkinsoniens

👁 Les effets anticholinergiques peuvent aussi entraîner une sécheresse oculaire

⚠ Une complication (heureusement rare) liée aux effets anticholinergiques est la survenue d'un glaucome à angle fermé :

- 📖 la mydriase entraîne une fermeture de l'angle où s'écoule l'humeur aqueuse (liquide dans la partie antérieure de l'œil)
- 📖 du fait l'augmentation de la pression intra-oculaire, l'œil devient rouge et douloureux, c'est une urgence médicale !
- 📖 cette complication peut être prévenue par un dépistage du glaucome à angle fermé (s'il est possible d'obtenir un RDV ophtalmo !) et par la réduction de la charge anticholinergique

! un glaucome à angle fermé peut être lié à d'autres mécanismes : le topiramate peut induire un oedème intra-oculaire avec myopie aiguë et augmentation de la pression intra-oculaire.

👁 Des mouvements involontaires des yeux sont des effets indésirables souvent très impressionnants mais sans gravité, survenant lors d'un traitement antipsychotique :

- 📖 la "crise oculogyre" se traduit par un blocage des globes oculaires dans une direction, le plus souvent vers le haut ("plafonnement")
- 📖 il s'agit d'une dyskinésie aiguë (contracture involontaire d'un groupe musculaire)
- 📖 comme toutes les dyskinésies aiguës, elle survient surtout en début de traitement et chez les adolescents et adultes jeunes
- 📖 cet effet disparaît rapidement avec des "correcteurs" anticholinergiques
- 📖 le traitement antipsychotique n'a pas à être diminué ou arrêté, sauf si cet effet persiste

👁 Les autres effets oculaires sont plus rares :

- 📖 en cas de prise prolongée avec exposition au soleil, les phénothiazines peuvent induire des réactions de photosensibilisation, avec des dépôts pigmentés composés de mélanine et phénothiazine sur la cornée, le cristallin et la rétine
- 📖 en début de traitement par lithium, une irritation oculaire peut survenir du fait de l'augmentation transitoire de la concentration en sodium des larmes

✚ un syndrome de l'iris hypotonique ("iris flasque") a été décrit avec les antipsychotiques (notamment rispéridone et palipéridone) avec des complications possibles au cours de la chirurgie de la cataracte

Références

<https://doi.org/10.2165/11533180-000000000-00000>

<https://doi.org/10.3390/jcm10132947>

